

「思い込み」が判断を狂わせる

— 利用可能性バイアスと医療安全

10 分 | 全スタッフ向け

「先週ノロウイルスの患者さんが続いた後、
今日も嘔吐の患者さんが来たら ...
つい“またノロかな”っていませんか？」

今日のゴール

1

説明できる

「利用可能性バイアス」が何かを
ざっくり説明できる

2

気づける

自分の仕事の中で「思い込み」が
起きやすい場면을 1 つ挙げられる

3

やってみる

明日から使える「思い込み防止」の
コツを 1 つ実践できる

私たちの脳は「ショートカット」が大好き

速い脳（直感モード）

パッと判断する
普段はこちらが大活躍

遅い脳（じっくりモード）

よく考えて判断する
時間とエネルギーが必要

忙しい医療現場では「速い脳」に頼りがち

ただし「速い脳」には思い込みのクセ（＝認知バイアス）がある

利用可能性バイアスってなに？

「最近見たもの・印象に残ったもの」を、
実際よりも多いと思い込むこと

日常の例：

飛行機事故のニュース → 飛行機が怖くなる
食中毒の報道 → 食品の鮮度が気になる

医療現場の例：

インフルエンザ 5 人連続 → 似た症状は全部インフル
前回の夜勤で転倒事故 → 転倒にだけ注意が向く

最新研究が示した衝撃の結果

BMJ Quality & Safety (2026 年 2 月) | 対象 : 1015 名の医師

発見	意味
直近 7 日以内に同じ病気の患者 を診た医師は誤診率が有意に上昇	最近の経験が判断を歪める
ベテランでも新人でも同じ傾向	経験年数だけでは防げない
「構造化されたフィードバック」を 受けている医師はバイアスが少ない	振り返りの習慣が大事

ポイント : 「たくさん経験していれば大丈夫」ではない!

医師だけの話? — 全職種に起きる「思い込み」

看護師

転倒が続いた → 身体拘束の判断に影響
急変があった → バイタル変動を過剰に心配

薬剤師

処方ミスを発見した薬 → その薬ばかりに注意
他の薬のチェックが甘くなる

事務・管理

クレームが多かった部署 → その部署の問題
ばかりが目につく

思い込みは全職種に起きます。だからこそチームで対策する意味がある

グループトーク（3 分間）

近くの人と話してみましょう：

「最近、“前と同じだろう” と思って
判断したことはありますか？
その判断は正しかったですか？」

2-3 人グループ / 正解・不正解は気にせず「あるある」を共有しましょう

共有タイム

グループで出た「あるある」を 1-2 グループから共有

ファシリテーターからのまとめ：

「思い込み」は能力の問題ではなく、脳の仕組みの問題

だから「気をつけよう」だけでは防げない → 仕組みが必要

明日から使える 3 つのコツ

立ち止まる

5 秒

判断する前に「本当に？
前回と同じとは限らないよね」と自問

声に出す

30 秒

「私は〇〇だと思う。他の可能性は？」
と同僚に一言聞く

書き出す

1 分

判断に迷った場面をメモしておき、
後で振り返る

今週 1 つだけ試してみましょう。どれを選びますか？

まとめと振り返り

1

利用可能性バイアス

最近の経験が判断を歪めること

2

防御策は経験年数ではない

振り返りとフィードバックの習慣

3

チームの力

一人で頑張るのではなく、声をかけ合う文化

確認：隣の人に「利用可能性バイアスって何？」を 30 秒で説明してみましょう